

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Trabectedin 1mg

[온 텔리스주사1.0 mg, 한국얀센]

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 바이알 중 트라벡테딘 1mg (trabectedin)

☐ **효능 효과 :**

- 안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2009년 제4차 약제급여평가위원회: 2009년 4월 23일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 비급여

- 신청품은 “안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종”에 사용하는 약제로 비교대상약제에 비해 임상적 유용성 개선이 불분명하고 비용이 고가에 해당하며, 외국 조정평균가보다 고가이고 임상사용상 필요한 함량의 제품(0.25mg) 신청되지 아니하였으므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종”에 허가받은 약제로 급여목록에 동일적응증에 허가 받은 약제는 없으나 급여 기준(건강보험심사평가원 공고)혹은 허가, 임상진료지침, 사전신청요법(신청기관인정요법) 등에 의할 때, gemcitabine+docetaxel 등 항암화학요법이 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서에 연조직육종에서 중요한 시험약으로 소개되고 있으며, 임상지침에서는 2차 치료제의 하나로 언급되고 있거나 추천약제에 포함되고 있지 않음.¹⁾²⁾³⁾
- 신청품은 기존 치료제와 직접 비교임상시험자료가 없으며 현재 온델리스의 효과에 대한 연구 결과가 충분하지 않음⁴⁾.
- 1차 이상 이전에 항암화학치료 받은 적이 있는 전이성 또는 절제 불가능한 국소 재발성 연조직 육종 환자(평가가능환자 99명)를 대상으로 매 3주마다 신청품 1.5 mg/m²을 투여한 다기관, 단일군 phase II 시험에서
 - 치료에 대한 반응은 8 부분반응(PR; 8%), 45 불변(no change)이었으며 TTP 중앙값 (median duration of the time to progression)은 105일, 6개월 무진행생존은 29% 이었음.
 - 독성은 주로 가역적인 grade 3 ~4의 무증후성의 transaminases 상승이 40%의 환자에서, grade 3~4의 neutropenia가 52%의 환자에서 관찰됨⁵⁾.
- 이전에 치료 받은 적이 있는 진행성 또는 전이성 연조직 육종 환자 54명에 대하여 신청품을 1,500μg/m²을 매 3주마다 투여 [(24-hour intravenous infusion)]한 Phase II 시험에서 전반적 반응률은 3.7% (2명에서 부분반응)임. 무진행생존 중앙값은 1.9 개월; 6개월에서 환자 24%가 무진행생존했음.⁶⁾

- 이전에 치료 받은 적이 있는 전이성 또는 재발성(이전 chemotherapy 에도 불구하고 진행한) 연조직 육종 환자 36명에 대하여 신청품을 $1,500\mu\text{g}/\text{m}^2$ 을 매 3주마다 투여한 Phase II 및 약동학 연구에서 전반적 반응률은 8% (완전반응 1, 부분반응 2)였음. 1년 TTP은 9% 였으며 1년 전반적 생존률은 53%였음. TTP 중앙값은 1.7개월 이었음⁷⁾.

○ 비용 효과성

- 교과서, 가이드라인, 학회의견 등에 2차 요법으로 제시되고 사전신청요법(허가 초과)으로 인정되고 있는 gemcitabine+docetaxel 요법을 대체가능약제 및 비교약제로 선정함
- 신청품과 비교약제의 단순 투약비용 비교 시 신청품은 1주기 투약 비용이 ■■■원⁸⁾으로 gemcitabine+docetaxel(■■■⁹⁾)과 비교할 때 고가에 해당하고 임상적 개선이 불분명하므로, 비용효과적이지 않음.
 - 신청품은 반응률 약 8%, TTP 3.5개월 등이었고, 비교약제(gemcitabine+docetaxel)는 gemcitabine과의 비교임상논문에서 반응률 약 17%(CR 3%, PR 14%), PFS 6.2 개월등임.

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상환자수를 참조하고, 체표면적을 $1.7(\text{m}^2)$ 로, 투여용량은 투여 주기 동안 동일하게 권장용량($1.5 \text{ mg}/\text{m}^2$)을 사용한다고 하면, 신청품의 도입 후 절대 재정소요금액은 도입 후 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 예상됨¹⁰⁾
 - 비교약제의 대체로 신청품 도입시 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 증가될 것으로 예상됨.
 - 신청품은 전처치 등을 하도록 되어 있으므로 이와 관련하여 재정이 증가할 수 있음

○ 제 외국 등재 현황

- A7 국가 중 독일과 영국에 허가되어 있음
- 신청품의 허가사항(용법용량)에 따라 0.25mg함량의 제품이 필요하고 외국에도 동 함량이 등재되어 있음을 고려할 때, 필요 함량이 모두 등재 신청되지 아니함¹¹⁾.
- 신청가격은 외국 조정평균가보다 고가임¹²⁾

REFERENCE

- 1) Cancer 8th
- 2) ESMO(2008)
- 3) NCCN 가이드라인(v1.2009)
- 4) 대한암학회(2008. 9. 30, 대암학 제 2008 - 84호)
- 5) A. Le Cesne et al. Phase II Study of ET-743 in Advanced Soft Tissue Sarcomas: A European Organisation for the Research and Treatment of Cancer (EORTC) Soft Tissue and Bone Sarcoma Group Trial J Clin Oncol.2005 Jan 20;23(3): 576-84
- 6) A. Yovine et al, Phase II study of ecteinascidin-743 in advanced pretreated soft tissue sarcoma patients. J Clin Oncol. 2004 Mar 1;22(5):890-9
- 7) Garcia-Carbonero et al, Phase II and Pharmacokinetic Study of Ecteinascidin 743 in Patients With Progressive Sarcomas of Soft Tissues Refractory to Chemotherapy. J Clin Oncol. 2004 Apr 15;22(8):1480-90
- 8) 신청품의 전처치비용(예,텍사메타손 20 mg■■■■)이 추가될 수 있음
- 9) Maki, et al. Randomized Phase II Study of Gemcitabine and Docetaxel Compared With Gemcitabine Alone in Patients With Metastatic Soft Tissue Sarcomas, J Clin Oncol. 2007;25:2755-2763 및 2008 약제의 연간 가중평균가 참조해 비용 산출. 신청기관의 용법용량에 따라 변동 가능. 전치료비용(docetaxel 예시, 경구용텍사메타손16 mg/일 ■■■■)이 추가될 수 있음.
- 10) 투여주기■■■■적용시임
- 11) 제약사 제출 신청품의 예상 사용량은 3차년도에 ■■■■바이알이며, 0.25mg는 ■■■■바이알 필요할 것으로 제출됨.
- 12) 접수월 전월 ■■■■ 평균 환율, ■■■■약가 적용,
 - 신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준: 1.4.2. 외국조정평균가외국조정평균가는 현재 보험급여 약제의 상한금약 조정기준(신의료기술등의결정및조정기준 제9조 제4항 제3호 관련[별표3])으로 이용되고 있는 바, 평가시의 신청가격이 이보다 높지 않도록 외국조정평균가를 급여 여부의 평가기준으로 함